随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

做手术难免损伤到骨膜

（2）一般先手法复位→没有影响局部血供、软组织，有利于愈合，达到功能复位即可（反复多次手法复位会造成损伤），不追求一定要达到解剖复位（但对于前臂双骨折为了保证旋转功能，必须达到解剖复位）

（3）切开复位 手法复位难达到解剖复位

①优点：更易达解剖复位（对位对线完全良好），提前下床活动，方便护理（减少关节僵硬和肌肉萎缩等）

不代表马上要做切开复位

②指征（老开旧功能、内部多处嵌入和损伤）：手法复位未达功能复位（关节内、前臂和小腿双骨折未达解剖复位）；骨折断端间有肌肉等软组织嵌入；并发主要血管、神经、韧带损伤，脊髓损伤；关节内骨折；不稳定骨折；多处骨折；陈旧骨折不愈合；老年人四肢骨折需尽早离床活动；开放性骨折 拖布入血

概论：问以下切开复位指征，选老年人四肢骨折✓
各论：看到老年人四肢骨折，就选切开复位✗
e.g肱骨近端骨折要看Neer分型



图 60-20　软组织嵌入骨折端之间

髋关节后脱位Epstein Ⅱ-Ⅴ型（合并关节内骨折）、中心脱位：切开复位+内固定



图 60-12　MRI 检查示 L_1 椎体压缩骨折合并脊髓损伤

关节内骨折→怕创伤性关节炎
手法复位 ××
解剖复位
切开复位

2.固定

复位+固定　损伤骨骺　颈椎骨折常用颅骨牵引
颈椎病常用颌枕带牵引（除脊髓型只能颅骨牵引）

①外固定：如牵引（也可复位）——皮肤、骨（儿童禁止）、枕颌带等

②内固定



图 61-2　锁骨骨折手法复位后横形 "8" 字绷带固定



图 61-8　肩关节前脱位的 Hippocrates 复位法



图 61-9　肩关节脱位复位后外固定法



图 61-19　肘关节后脱位的复位方法



图 61-20　手法复位后石膏托固定



图 61-25　尺桡骨双骨折的上肢管形石膏固定

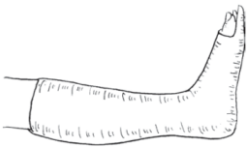


图 60-24　小腿石膏绷带固定



图 60-25　支具固定用于颈椎损伤和上臂骨折或损伤





图 60-26　枕颌带牵引



图 60-27　颅骨牵引

颈椎骨折

禁用于脊髓型颈椎病



图 63-19　儿童的垂直悬吊皮肤牵引

<3岁股骨干骨折

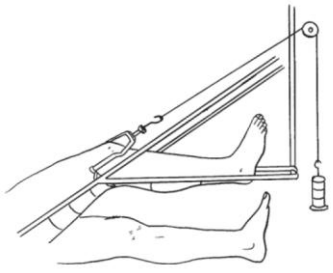


图 60-28　股骨骨折行股骨髁上骨牵引

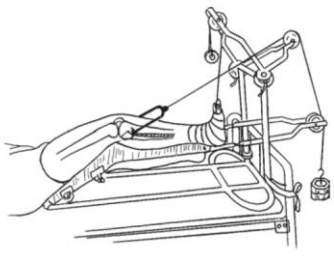


图 60-29　股骨骨折行胫骨结节骨牵引

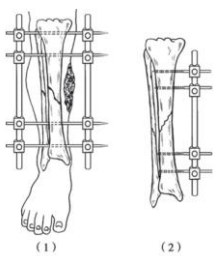


图 60-31　骨外固定器适用于治疗开放性骨折，便于处理伤口
（1）双边外固定器　（2）单边外固定器

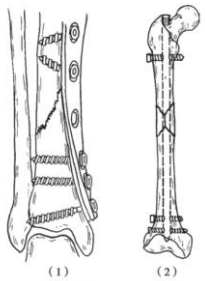


图 60-32　骨折内固定
（1）金属接骨板内固定　（2）带锁髓内钉内固定

针对小腿双骨折
内固定更牢靠，因为小腿承重
但对时间长污染重的小腿双骨折，先用外固定架

3.功能锻炼：在不影响固定的情况下尽早功能锻炼